Université de Bejaia
Faculté de Médecine de Bejaia
Module de Sémiologie Médicale
UE 3

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

faculté de médecine de béjaia

Sémiologie de la motricité 3

▪ Mouvement anormaux

Dr Terra. Service de médecine interne du CHU Bejaia

Sémiologie
des mouvement anormaux

Tremblements

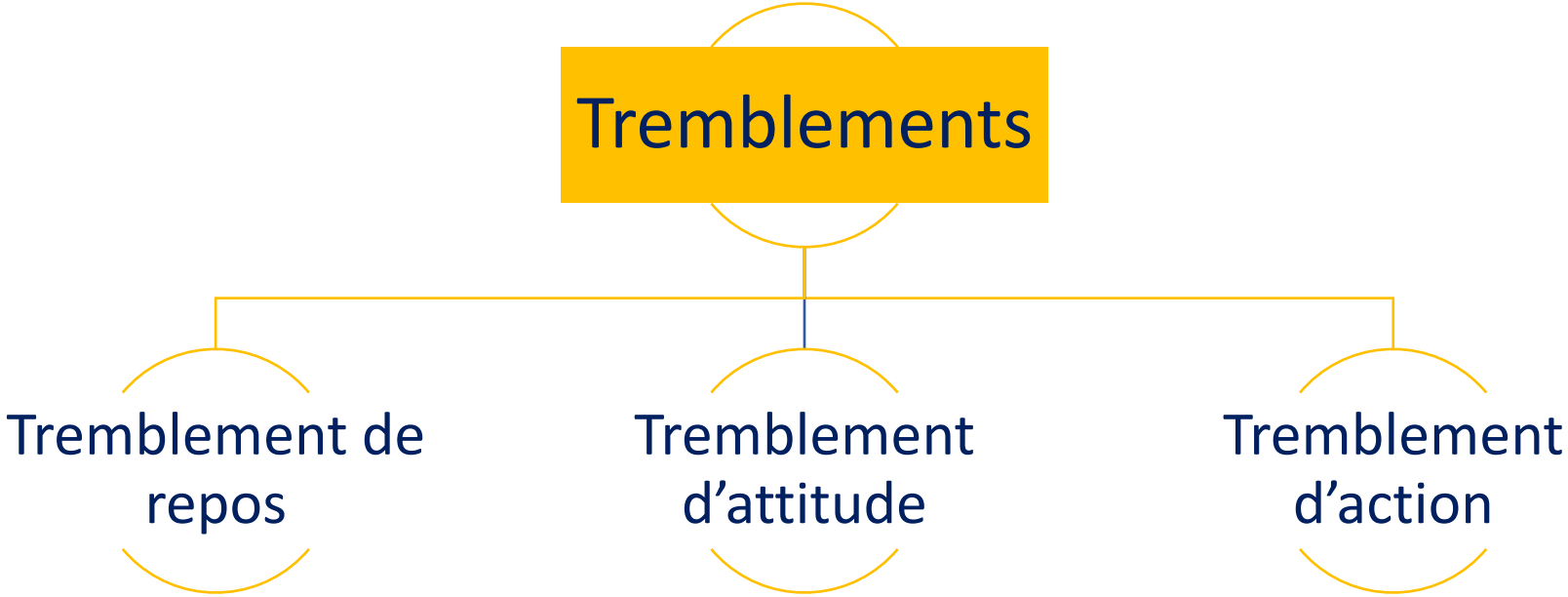


tremblement

- Oscillation rythmique involontaire de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre.

- Le plus souvent observé aux niveau des mains




Tremblements
Tremblement de repos
Tremblement d’attitude
Tremblement d’action

Tremblement de repos

- présent au repos et disparaissant lors du mouvement
- lent
- Touche :
  - les membres
  - les lèvres
  - le menton
- aggravé par les émotions et le calcul mental

- Examiné en position de repos
- mains reposant sur un plan
- malade décontracté

→ maladie de Parkinson +++

Tremblement d’attitude

- Exagération le plus souvent d’un **tremblement physiologique**
- apparaît lors du **maintien volontaire d'une attitude**
- Perturbe les gestes de la vie courante
- **Absent au repos**
- prédilection pour les membres supérieurs
- augmente si la position est maintenue

Causes fréquentes :

- Essentiel +++
- physiologique
- Hyperthyroïdie
- médicamenteux

Tremblement d’action

- Apparait au cours d’une **action**
- Surtout pour un **mouvement volontaire** nécessitant une **précision du geste**
- maximal lors de l'arrivée à la cible (épreuve doigt-nez)
- rapide

→ associé à un syndrome cérébelleux ++++

Principaux mouvement anormaux

mouvements anormaux

- **activité motrice** indépendante de la volonté, survenant à **l'état de veille**
- résultent d'une attente des **noyaux gris centraux** pour la plupart d'entre eux
- Peuvent être rythmés et réguliers (tremblements) ou non rythmés.

mouvements
involontaires
+++

Les mouvement anormaux

deux caractéristiques :

→ involontaires

→surviennent en l'absence de paralysie

- **Les mouvements anormaux correspondent à un trouble de la programmation et/ou de l'exécution du mouvement.**

- La reconnaissance des différents types de mouvements anormaux n’est pas aisée, elle repose sur l'**observation clinique réelle,** par **la description du patient ou de son entourage** et parfois par un **enregistrement vidéo**

- Rôle de l’anamnèse +++ .

- Rechercher toujours les ATCD personnels et familiaux, le mode de début, l’évolution, les signes accompagnateurs

- Rechercher toujours **cause médicamenteuse** (traitements utilisés en neurologie et en psychiatrie) et un **terrain génétique**

mouvement athétosique

- mouvement involontaire
- lent, irrégulier, incessant
- **prédomine aux extrémités**

- Déplacements lents et asynchrones des doigts avec écartement et alternances de **flexion extension** des articulations métacarpo-phalangiennes
- hyper-extension spontanée des orteils
- région buccale : grimaces lentes

mouvement athétosique

- aggravé par la fatigue et les émotions
- Amélioré par le repos et le sommeil
- Association une hypertonie

Athétose











dystonies

- **contractions musculaire involontaires** et intermittentes localisées
  à certains groupes musculaires avec **mouvement et/ou posture anormale**

- peuvent être prolongées
- focales +++ ou généralisés (rares)

- survenue lors du maintien d’une attitudes ou lors de l'exécution
  des mouvements volontaires

Dystonies

- Dystonie du cou → **torticolis spasmodique** (torsion du cou)
- Dystonie de la main → **crampe des écrivains** (lors de l'écriture)
- Paupières → **blépharospasme**



Torticolis à droite, noter l'asymétrie des muscles sterno-cleido-mastoidiens



Dystonie la main et du pied

Chorée

- agitation motrice **involontaire**, incessante et anarchique

- mouvements brusques, brefs, aléatoires
- amplitude, fréquence et intensité variables
    - visage : grimaces et mimiques
    - membres : mouvements amples de flexion-extension
    - Contorsions au niveau du tronc

augmentés par :

- efforts intellectuels
- activité physiques
- fatigue
- émotion



Chorea

hémiballisme

- mouvements d'apparition brutale
- involontaires, stéréotypés
- amples, brefs
- racine des membres, **distribution hémicorporelle**

→ **membre supérieur ++ : projection du membre supérieur en avant et en dehors avec rotation de l'épaule**

augmentés par :
- efforts intellectuels
- efforts physiques
- fatigue
- émotion



Hemiballism (left)

Myoclonies

- **contractions musculaires brèves** et involontaires, avec déplacement d'un segment de muscle, d'un muscle entier ou d'un groupe de muscles.
- secousses musculaires brusques
- non rythmées
- focales, multifocales ou généralisées

Causes des myoclonies

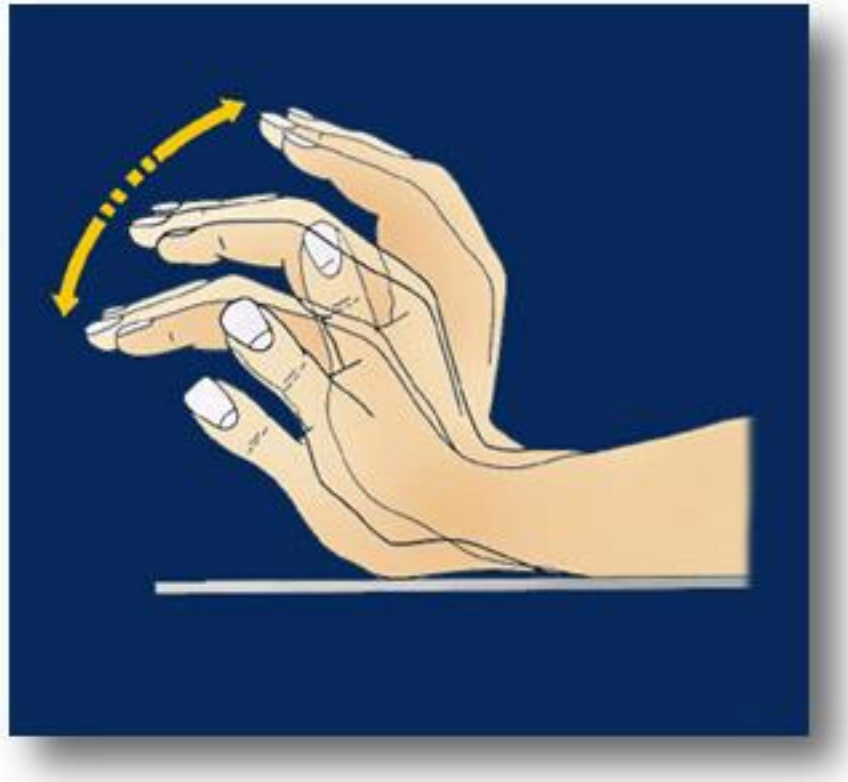
- **encéphalopathies métaboliques** (hépatique, respiratoire, rénale)
- toxiques
- infectieuses
- pathologies neurodégénératives du SNC
- **maladie de Creutzfeldt-Jakob (maladie de la vache folle !)**
- épilepsies myocloniques
- causes médicamenteuses (antidépresseurs)

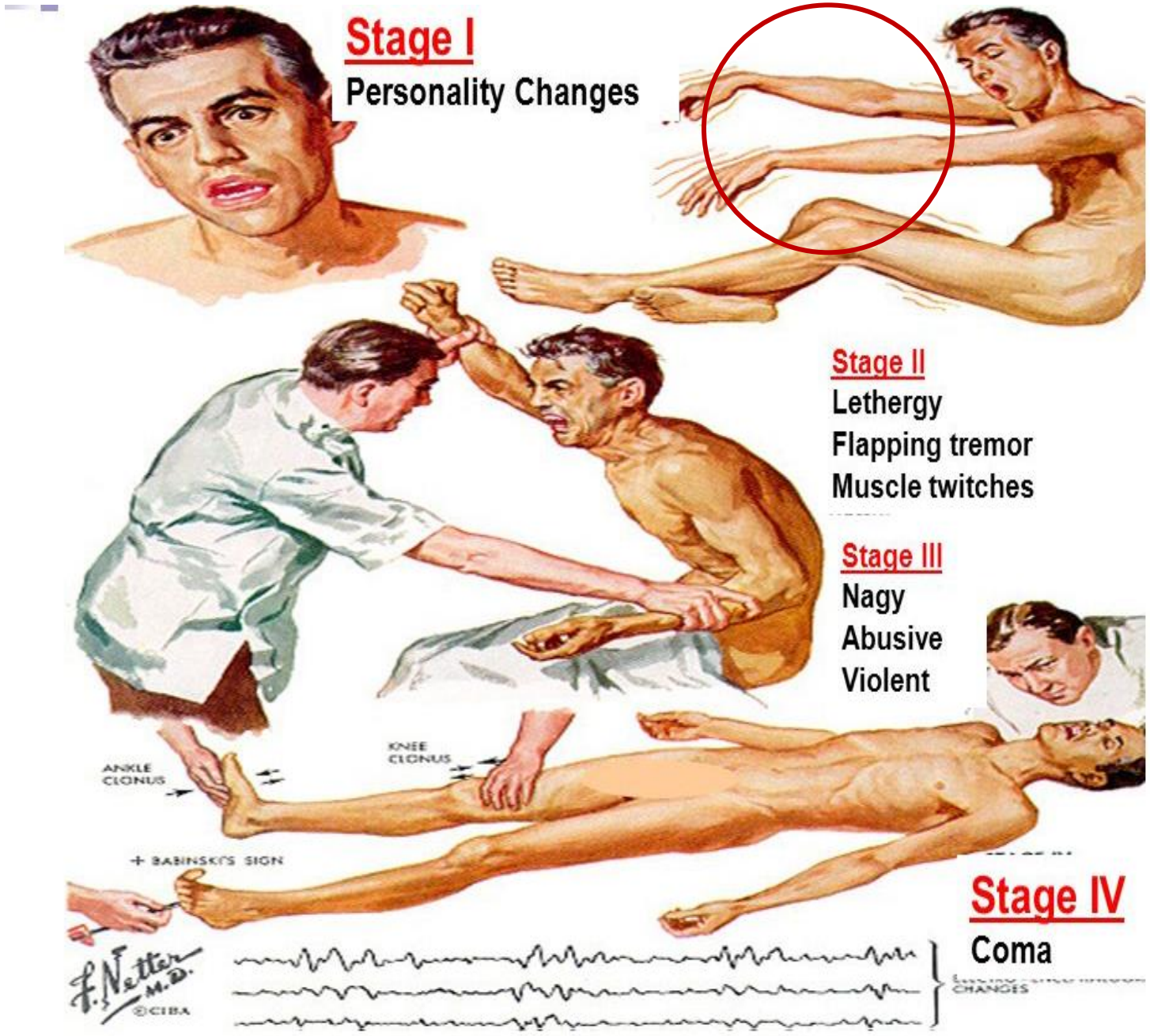
asterixis

variété de myoclonies → **chute du tonus**
Appelé aussi Flapping tremor

malade les bras tendus → brusques mouvements involontaires de flexion-extension des poignets

- Ce signe est observé dans les premiers stades d'une **encéphalopathie hépatique +++**
- **Cirrhose avec Insuffisance hépatocellulaire**




Stage I
Personality Changes
Stage II
Lethergy
Flapping tremor
Muscle twitches
Stage III
Nagy
Abusive
Violent
ANKLE CLONUS
KNEE CLONUS
+ BABINSKI'S SIGN
Stage IV
Coma
F. Netter M.D.
©CIBA

asterixis

Autres Causes :

- Insuffisance respiratoire sévère (hypoxémie, hypercapnie)
- Insuffisance rénale (urémie élevée)
- Maladie de wilson
- Médicaments (antiépileptiques, benzodiazépines, lithium)
- Certaines infections du système nerveux central

Les TICS

- mimant souvent un geste normal
- prédominent à la tête et au cou
- Le tic simple touche quelques muscles :

    - clignement des yeux.
    - secousse de la tête.
    - haussement des épaules

- Le tic complexe correspond à une séquence motrice élaborée.
- → **involontaires**

majorés par :
- Fatigue
- stress
- émotion

disparition pendant le sommeil

Contrôle transitoire par la volonté suivi souvent d'un rebond

Les Tics

- Mouvements brefs
- **Parfois vocalisation (sons)**
- soudains
- stéréotypés
- Intermittents
- Répétitifs

Tics vocaux :

- Cri
- Reniflement
- raclement de gorge
- Expiration forcée


SOLUS

Références :

- **R.M.Hamladji**, Précis de sémiologie, OPU
- **Collège des enseignants de sémiologie** en France: polycopié enseignement en sémiologie
- **Collège des enseignants de neurologie** en France. **https://www.cen-neurologie.fr**
- **Neurologie**, éditions Elsevier Masson ISBN : 978-2-294-76169-0

Merci de votre Attention